

利用可能性バイアスと診断推論

— あなたの診断は「記憶」に支配されている？

15 分 | 研修医・専攻医向け

「先週インフルエンザを 5 人診た翌週、
咳と発熱の患者さんが来たら何を考えますか？」

学習目標

1

説明できる

利用可能性バイアスの定義と
発生メカニズムを自分の言葉で説明できる

2

批判的に吟味できる

Moura et al. (2026) の研究デザイン・
結果・限界を分析できる

3

計画を立てられる

自身の臨床推論でバイアスを軽減する
構造化された振り返りを設計できる

認知バイアスの復習 — System 1 と System 2

System 1（速い思考）

直感的・自動的・省エネ
臨床のほとんどの判断

System 2（遅い思考）

分析的・意識的・高負荷
複雑な鑑別診断

認知バイアスは System 1 のショートカット（ヒューリスティクス）から生じる

利用可能性バイアス： 思い出しやすい情報を過大評価

アンカリング： 最初の情報に固執する

確証バイアス： 自分の仮説を支持する情報ばかり集める

利用可能性バイアスとは何か

記憶から容易に想起できる情報を、
実際の頻度や確率よりも重要視する認知傾向

Tversky & Kahneman (1973) が最初に記述

臨床場面での発動条件：

直近の経験

先週同じ疾患を診た

感情的インパクト

印象に残った重症例

メディア露出

ニュースで話題の疾患

例：インフルエンザ流行期に連続で診断した後、同じ症状の市中肺炎を見逃す

研究紹介 — Moura et al. (2026)

BMJ Quality & Safety (2026 年 2 月)

DOI: 10.1136/bmjqs-2025-019520

デザイン

横断調査 (Cross-sectional study)

対象

1015 名の医師 (複数の専門科・経験年数)

方法

臨床ビネット (仮想症例) を用いた診断課題

主要曝露

直近 7 日以内に特定疾患の患者を診察した経験の有無

主要アウトカム

誤診率

主要結果

指標	値	意味
回帰係数 (b)	0.165	直近の臨床遭遇が誤診率を有意に上昇させる
p 値	0.018	統計的に有意
経験年数の影響	有意でない	年数を重ねても自動的にバイアスは減らない

核心的メッセージ

「たくさん診ている」こと自体はバイアス軽減にならない

重要なのは「構造化された経験」と「フィードバック」の蓄積

批判的吟味 — この研究の強みと限界

強み

大規模サンプル（ $n=1015$ ）

実際の臨床経験を曝露変数として使用

複数の専門科を横断的に調査

限界

横断研究のため因果関係は断定不可

臨床ビネットは実臨床の複雑性を再現しない

自己申告ベース（想起バイアス）

「構造化された経験」の定義が曖昧

関連 : AJM (2025) — 認知バイアスが過剰検査につながるメカニズムも報告

ペアディスカッション（4 分間）

問い 1: 「自分が直近の経験に引きずられて
診断を変えた（または変えそうになった）
エピソードはありますか？」

問い 2: 「その時、何がきっかけで
気づけた（または気づけなかった）のか？」

1 人 2 分ずつ / 具体的な症例でなくても「あのとき危なかった」レベルで OK

共有とフィードバック

全体共有（2-3 名から）：

どんな場面で利用可能性バイアスが発動しやすいと感じた？

「気づけた」要因は何だった？

ファシリテーターからの補足ポイント：

「忙しい時ほど System 1 に頼りがち」

「一人で診断を完結させる場面」が最もリスクが高い

フィードバックなしの経験は「バイアスの強化練習」になりうる

利用可能性バイアスへの対策

個人レベル

1. 診断タイムアウト

最初の仮説後、10 秒間
「他の可能性」を考える

2. 鑑別リストの外在化

紙やカルテに 3 つ以上の
鑑別を書き出す

3. 診断日記

自分の診断パターンを
記録し定期的に振り返る

システムレベル

1. 構造化されたカンファレンス

診断過程のプロセスを
振り返る場の設計

2. ピアレビュー

同僚との診断共有と
相互フィードバック

3. チェックリスト活用

認知バイアスに対する
構造化された防御策

振り返りと理解度確認

Q1

利用可能性バイアスの定義を一文で述べてください

Q2

この研究で、経験年数は誤診率の軽減に有意だったか？

Q3

経験年数ではなく何が重要だと結論されたか？

持ち帰りの問い — 明日の臨床から

今週 1 つだけ試すなら：
外来で最初の診断仮説を立てた直後に、
「本当にそうか？ 先週の経験に
引きずられていないか？」と自問する 10 秒間を作る

さらに深めたい人へ：

Croskerry P. (2009) Academic Medicine — 診断推論の普遍的モデル

Kahneman D. (2011) Thinking, Fast and Slow (ファスト & スロー)

Moura EC et al. (2026) BMJ Quality & Safety

AJM (2025) Over-investigation and cognitive bias